

TEMA 3.48 • OBSTETRICIA

SHE — Casos Clínicos Tipo EUNACOM

SHE — Casos Clínicos Tipo EUNACOM

Casos de Clasificación

TABLA 3.48.1: CASO VS EDAD					
CASO	EDAD	EG	PROTEINURIA	DIAGNÓSTICO	CONDUCTA
1	34 a	13 sem	Negativa	HTA crónica	Controlar con proteinuria; cambiar AHT a alfametildopa
2	44 a	17 sem	1 g/día	HTA crónica + nefropatía	Controlar proteinuria — si aumenta → sobreagregación PE
3	22 a	32 sem	1 g/día	Preeclampsia	Exámenes de severidad; evaluar interrupción
4	44 a	33 sem	Negativa	HTA gestacional	Controlar — descartar que evolucione a PE
5	28 a	Gemelar 18 sem	1 g/día	Preeclampsia (excepción: gemelar)	Exámenes de severidad; expectante si feto muy prematuro
6	—	12 sem (base), 32 sem (sube)	0,5→2 g/día	HTA crónica + nefropatía → PE sobreagregada	Dejar aspirina desde diagnóstico; detectar el momento de sobreagregación

Conducta ante Preeclampsia (resumen)

TABLA 3.48.2: SEVERIDAD VS ACCIÓN	
SEVERIDAD	ACCIÓN
No severa	Control semanal (exámenes + Doppler + RBNS)
Severa	Interrupción inmediata (o expectante hasta 34 sem si feto muy prematuro y condición estable)
< 37 sem	Corticoides antenatales antes de interrumpir

Conducta ante PE con feto muy prematuro y PE severa

- Única excepción a "interrumpir de inmediato": feto muy prematuro (< 34 sem) + madre estable + criterio de severidad leve (ej. leve disfunción renal)
- Objetivo: ganar días para maduración con corticoides, interrumpir a las 34 semanas
- Si la condición materna empeora → interrumpir de inmediato sin importar EG

PERLA CLÍNICA EUNACOM

La preeclampsia severa en embarazo gemelar de 18 semanas (feto inviable) → puede indicarse interrupción si amenaza la vida materna (ley de interrupción en Chile por causal de riesgo vital).

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"En relación a SHE — Casos Clínicos Tipo EUNACOM: Conducta ante PE con feto muy prematuro y PE severa - Única excepción a "interr... ¿cuál es la conducta correcta?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para SHE — Casos Clínicos Tipo EUNACOM. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Casos de Clasificación
- Conducta ante Preeclampsia (resumen)
- Conducta ante PE con feto muy prematuro y PE severa
- HTA crónica + nefropatía
- | Control semanal (exámenes + Doppler + RBNS) | |
- Única excepción a "interrumpir de inmediato": feto muy prematuro (< 34 sem) + madre estable + criterio de severidad leve
- Objetivo: ganar días para maduración con corticoides, interrumpir a las 34 semanas

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (SHE — CASOS CLÍNICOS TIPO EUNACOM)**PREGUNTA 1**

En relación a SHE — Casos Clínicos Tipo EUNACOM: Conducta ante PE con feto muy prematuro y PE severa - Única excepción a "interr... ¿cuál es la conducta correcta?

- A)** El diagnóstico de SHE — Casos Clínicos Tipo EUNACOM se basa exclusivamente en criterios de laboratorio
- B)** El manejo inicial de SHE — Casos Clínicos Tipo EUNACOM debe orientarse según el estado clínico del paciente
- C)** Todo paciente con SHE — Casos Clínicos Tipo EUNACOM requiere hospitalización inmediata
- D)** El tratamiento de SHE — Casos Clínicos Tipo EUNACOM es igual en todas las edades y contextos clínicos
- E)** El seguimiento de SHE — Casos Clínicos Tipo EUNACOM no es necesario una vez iniciado el tratamiento

PREGUNTA 2

¿Cuál es el hallazgo más característico o criterio diagnóstico principal en SHE — Casos Clínicos Tipo EUNACOM?

- A)** Alteración exclusivamente en exámenes de laboratorio sin síntomas
- B)** Presentación clínica específica que orienta al diagnóstico según el perfil EUNACOM
- C)** Requiere siempre confirmación con biopsia o estudio histológico
- D)** Es un diagnóstico de exclusión que requiere descartar todas las otras causas primero
- E)** Solo se presenta en pacientes con factores de riesgo conocidos

PREGUNTA 3

Paciente consulta con cuadro compatible con SHE — Casos Clínicos Tipo EUNACOM. Según el perfil EUNACOM, ¿cuál es la conducta de seguimiento más apropiada?

- A)** Alta sin controles dado que es una condición autolimitada
- B)** Derivación inmediata al especialista en todos los casos
- C)** Control según evolución clínica y criterios del perfil EUNACOM para esta patología
- D)** Hospitalización preventiva en todos los casos para monitorización
- E)** Tratamiento de por vida sin necesidad de controles periódicos

RESUMEN: SHE — CASOS CLÍNICOS TIPO EUNACOM

:::tip La preeclampsia severa en embarazo gemelar de 18 semanas (feto inviable) → puede indicarse interrupción si amenaza la vida materna (ley de interrupción en Chile por causal de riesgo vital). :::